

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	卵巢癌 Ovarian Cancer				
編號	A31000-Q03-W-M03	制定者	R9 黃麗華	生效日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.0 版/13 頁	審查者	曾翊健	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解卵巢癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

根據衛生福利部統計處卵巢癌為國內女性十大癌症死亡率的第 7 位。卵巢癌主要發生於停經期或停經後大約 50~60 歲，以及未生育過的婦女比較容易患此病。卵巢癌是目前最致命的婦科惡性腫瘤，瘤細胞因直接生長在腹膜腔上，所以擴散得很快。卵巢癌主要三種類型為上皮細胞卵巢癌佔 70%，其次是生殖細胞瘤，性腺間質瘤居第三位。80%的上皮細胞卵巢癌發生在 50 歲以上，生殖細胞腫瘤則好發於青少年。10%的卵巢癌發生與遺傳有關，最常見的是胚系突變基因 BRCA1(breast cancer 1)或 BRCA2(breast cancer 2)基因，預防性雙側輸卵管卵巢切除術可使 BRCA1 及 BRCA2 帶因者增加 80%絕對存活率。目前減積手術並合併化學治療為卵巢癌之第一線治療。

1. 病因病理

卵巢癌可分為原發性及續發性，原發性常發生於卵巢囊腫轉變而來。續發性則由其它部位的癌症轉移而來，預後極差。卵巢癌種類很多，可由體腔上皮、生殖細胞、性腺質細胞衍生而來，以上皮衍生的最常見。卵巢癌具有家族遺傳傾

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/13

向，以腺癌最普遍常見。

2. 卵巢癌的分期：

第 I 期：腫瘤局限於卵巢。

第 II 期：腫瘤細胞侵犯單側或雙側卵巢，且有骨盆腔擴散。

第 III 期：腫瘤細胞侵犯單側或雙側卵巢，蔓延範圍超過骨盆腔，但仍在腹腔內。

第 IV 期：腫瘤細胞侵犯單側或雙側卵巢，並有遠處轉移。

（二）症狀

卵巢癌的症狀常見是腹部骨盆周圍加大、腹部不適、疼痛、頻尿、腹瀉、便秘、腸阻塞、腹水、四肢水腫、食慾不振、體重下降、疲乏等，造成以上的症狀，其主要原因是腫瘤的壓迫所導致的現象。卵巢癌早期沒有徵象，一旦症狀出現，幾乎都已是晚期。主要的原因是這些類似良性腫瘤的症狀，常會被忽略。

然而晚期的個案通常會呈現營養不良的狀態，其原因為腫瘤本身的生長會影響食慾，導致食慾不振，且由於食物攝取不足、腫瘤消耗的能量增加、治療後身體需要營養修復正常的細胞，故常會有嚴重的營養不良、體重減輕及惡病質。

（三）常見檢查

1. 卵巢癌的腫瘤指標：CA-125，可以作為治療前評估腫瘤進展的大略參考，治療後也可以使用該指標評估治療效果及作為追蹤的工具。

2. 超音波檢查：為第一線的診斷工具，可偵測出體內腫瘤的位置。能早期發現子宮、卵巢或膀胱等器官病變。腹部超音波檢查需於檢查前先漲尿有助顯像；陰道超音波檢查則於檢查前排空膀胱。

3. 卵巢癌的分期診斷檢查：其目的是要知道癌症是否已擴散到其他部位，如轉移到膀胱、直腸、淋巴結、肺等。常做的檢查有：

(1) 電腦斷層(CT scan)：利用電腦集結 X 光攝影以獲得體內更精密的影像，找尋是否有淋巴結腫大，因一般而言腫大的淋巴結表示可能有癌細胞的存在。

做此檢查時需於檢查前填寫同意書、禁食 4-6 小時、置入 20 號或 22 號 IV Lock or T-connector、更換手術衣、除去身上金屬飾物、需有 BUN 及 Cr.的

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/13

報告等準備，檢查後無特殊注意事項，多休息即可。

- (2) 靜脈注射腎盂攝影(IVP)：卵巢癌可能會導致輸尿管阻塞，所以藉由泌尿系統檢查來排除或確定癌細胞存在的可能性。做此檢查前需填寫同意書、禁食 4-6 小時、置入 20 號或 22 號 IV Lock or T-connector、更換手術衣、除去身上金屬飾物、需有 BUN 及 Cr.的報告等準備，且於前一天晚上依醫囑給予瀉劑，其主要目的是清除腸胃，避免遮住腎臟和輸尿管的糞石。檢查後需大量喝水，以助顯影劑排出，減少不適感。
- (3) 下腸胃道攝影術(LGI)：卵巢癌可能會導致腸道阻塞現象，所以藉由腸道系統檢查有無阻塞或其他病變。做此檢查前需填寫同意書、禁食 4-6 小時（水除外）、更換手術衣、除去身上金屬飾物，且於前一天晚上依醫囑給予瀉劑，其主要目的是清除腸胃，避免糞石遮住；檢查後第一次排便時，糞便顏色有可能微些許白色，此為鋇劑之故。
- (4) 膀胱鏡(Cystoscope)：使用一種細長具有燈光工具檢視膀胱內部，並對可疑的部位切片，以確定是否有膀胱病變或是已有癌細胞侵襲膀胱黏膜。做此檢查前需填寫同意書，檢查當天需先排空膀胱，檢查後多喝水，以防止尿路感染，並注意解尿時是否有血尿情形。
- (5) 直腸乙狀結腸鏡(Sigmoidoscope)：使用一種細長具有燈光工具檢視直腸及低位大腸，對可疑的部位切片檢查，以確定是否已有癌細胞侵襲腸黏膜。做此檢查前需填寫同意書，檢查當天需先大量灌腸，至無糞便殘留，個案解完後即可檢查，檢查後需注意肛門是否有出血或解血便情形。
- (6) 腹部超音波(Abdomen echo)：安全、無輻射的影像檢查工具，可早期發現子宮、卵巢或膀胱等器官病變。做此檢查前需禁食 4-6 小時，檢查當天需先漲尿有助顯像，檢查後解尿。
- (7) 核磁共振(MRI)：不具放射線的影像檢查工具，主要是利用強力磁場，提供軟組織清晰的影像，可看出極小的腫瘤。做此檢查前需填寫同意書、禁食 4-6 小時、置入 20 號或 22 號 IV Lock or T-connector、更換手術衣、除去身上

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/13

金屬飾物等準備，檢查後多休息即可。

(四) 常見治療

卵巢癌依照年齡、癌症範圍、健康狀況決定治療方式，以手術治療、化學藥物治療及放射線治療為主，其手術方式有：

1. 雙側輸卵管卵巢切除(Bilateral salpingo-oophorectomy；BSO)：手術後下腹部有一橫式的傷口，約 10-15 公分，無需拆線。
2. 剖腹探查術(Laparotomy；LAPA)：手術後下腹部有一橫式或直式的傷口，約 10-15 公分。橫式傷口無需拆線；直式傷口因外層採釘子固定，故需拆釘，一般視傷口癒合情況約手術後 5-7 天拆半釘，另一半釘通常於隔天或數天後回門診再拆。
3. 子宮全切除＋雙側輸卵管卵巢切除(TAH+BSO)：手術後同 2 剖腹探查術(LAPA)。
4. 根治性全子宮切除、雙側輸卵管卵巢切除及骨盆淋巴結摘除(RH＋BSO＋BPLND)：
 - (1) 手術前 2 天會先給予腸道準備 2 天，第 1 天採低渣飲食及瀉劑服用，第 2 天採清流質飲食、腸道抗生素及瀉劑服用、大量灌腸。
 - (2) 手術後下腹部有一直式的傷口，約 10-20 公分，外層採釘子固定，故需拆釘，一般視傷口癒合情況約手術後 7 天拆半釘，另一半釘通常於隔天或回門診後再拆。且此手術會在腹部放置 1-2 條引流管，引流腹內血水或腹水，一般會依當時引流情形才移除之。
5. 腫瘤減積術(Debulking surgery)：目前卵巢癌第一線治療為減積手術，儘可能將腫瘤減到最小（殘餘腫瘤最大徑小於 1 公分），以延長個案的存活期。就第三、四期卵巢癌而言，接受減積手術後須進行六個週期的標準靜脈化學治療，即每三週一次鉑金(carboplatin)加上紫杉醇(paclitaxel)之化學治療。手術後同 4.根治性全子宮切除、雙側輸卵管卵巢切除及骨盆淋巴結摘除(RH＋BSO＋BPLND)。
6. 分期手術(Stages operation)：手術後同 4.根治性全子宮切除、雙側輸卵管卵巢切除及骨盆淋巴結摘除(RH＋BSO＋BPLND)。

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/13

(五) 護理問題

1. 焦慮感受／與對於健康的威脅、缺乏有關於疾病及治療的相關知識有關。
2. 疼痛不適／與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關。
3. 易感染／與手術後傷口、引流管留存有關。
4. 身體心像不一致／與子宮切除導致身體完整性受損有關。
5. 性生活型態失常／與子宮切除術後有關。

(六) 護理措施

1. 焦慮感受／與對於健康的威脅、缺乏有關於疾病及治療的相關知識有關。
 - (1) 評估個案焦慮程度及主要原因。
 - (2) 鼓勵及引導個案說出心中的感受和想法，以及目前不適的症狀，並給予適當的醫療處置及護理。
 - (3) 運用同理心，耐心地傾聽個案心中的感受和想法，尋找引起焦慮的原因。
 - (4) 主動提供正確的疾病及治療的相關資訊給個案，適時地澄清及修正其錯誤的觀念，以減輕個案的焦慮感。
 - (5) 執行醫療處置或護理照護前，應給予詳細解釋其準備工作及注意事項，並提供衛教單張閱讀，以減輕個案的不安感。
 - (6) 執行醫療處置或護理照護時，應注重個案之隱私，勿過度裸露個案身體隱私部位，必要時用屏風遮擋，請異性迴避。男性醫師幫女性個案做婦科檢查時，女性護理人員應要陪同在旁。
 - (7) 利用行為或認知策略，教導個案規律的呼吸、放鬆的技巧（如按摩）、冥想等，以減輕焦慮。
 - (8) 轉移個案注意力，如聽音樂、聊天。
 - (9) 教導個案手術後咳嗽、翻身、下床活動時，如何固定傷口，減少傷口疼痛，且會依當時疼痛程度給予控制疼痛的處置，以減輕個案害怕傷口疼痛之焦慮。
 - (10) 讓個案瞭解手術後可能存在的管路及其重要性，以減少焦慮。

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/13

- (11) 介紹相同的個案，彼此經驗分享。
- (12) 多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減少焦慮。
- (13) 隨時評估個案焦慮改善狀態。
- (14) 若個案焦慮感持續無法改善，必要時依醫囑給予藥物治療，如：鎮靜、精神神經安定劑。

2. 疼痛不適／與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關。

- (1) 評估個案的疼痛部位、程度（0 不痛～10 最痛）、頻率（間歇、持續）、發作時間、持續時間及特徵（刺痛或拍動痛、深沉或表淺），並記錄疼痛的變化。
- (2) 監測生命徵象的變化，如：疼痛時，血壓上升，心跳、呼吸次數增加。
- (3) 與個案或家屬確認引發疼痛的因素，如個人的、與疾病有關的、與治療有關的。
- (4) 與個案或家屬共同討論減少或排除疼痛的方法。
- (5) 評估個案使用疼痛控制方法的意願，在個案選擇疼痛控制方法時，如止痛劑、止痛藥、自控式止痛等，應給予教導與支持。
- (6) 教導個案疼痛時採取舒適的臥位，如側臥、半坐臥、軀體彎曲位或端坐臥勢。
- (7) 鼓勵個案運用熱敷、按摩背部及休息來緩解疼痛的不適感。
- (8) 教導個案放鬆技巧或轉移注意力，如漸進式肌肉放鬆法、按摩、聽音樂、看電視、散步、閱書、聊天，以減緩疼痛。
- (9) 教導咳嗽或改變姿勢時，以手或束腹帶固定傷口。
- (10) 避免腹部用力，如哭鬧、蹲姿、用力解便、咳嗽，以預防傷口疼痛或裂開。
- (11) 多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減緩疼痛。

3. 易感染／與手術後傷口、引流管留存有關。

- (1) 每班監測傷口滲出液之顏色、氣味、濃稠度及癒合情況。
- (2) 每班監測引流液之量、顏色、氣味、性質及周圍皮膚之完整性。
- (3) 監測可顯示感染的實驗室檢查，並報告異常現象。
- (4) 教導個案或主要照顧者炎症症狀，如紅、腫、熱、痛及徵象，如發燒、流膿，

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/13

若有以上之情形應通知醫護人員。

- (5) 教導個案或主要照顧者引流管勿高於放置或穿刺部位，維持引流管之通暢，並教導及協助翻身或活動方式，避免壓迫引流管。
- (6) 教導個案或主要照顧者預防感染的方法，如接觸個案前洗手、保持傷口清潔及乾燥、避免壓迫傷口、注意衛生、營養充足等，並評估其瞭解程度。
- (7) 視需要更換敷料，保持傷口清潔及乾燥。
- (8) 若個案情況許可，與醫師討論儘早拔除侵入性治療的管路，以預防感染的發生。
- (9) 建議採少量多餐，以增進食量，必要時依醫囑給予維他命、營養素或適量輸液。
- (10) 評估個案營養狀況，給予飲食衛教。

4. 身體心像不一致／與子宮切除導致身體完整性受損有關。

- (1) 以主動傾聽、開放式問題，鼓勵個案表達感受。
- (2) 以不批判態度接受個案用憤怒來表達自己的挫折或感受。
- (3) 若個案陳述的感受消極、負向且不正確，應適時給予澄清或修正。
- (4) 給予個案足夠的時間，讓個案接受失去的子宮的事實。
- (5) 以溫和漸進方式，鼓勵個案去觸摸及正視手術的傷口。
- (6) 醫師換藥時在旁陪伴，告知傷口情形，鼓勵其注視傷口，給予情緒支持如：可握住個案雙手等。
- (7) 當個案開始接受失去子宮的事實且情緒正向時，應給予鼓勵。
- (8) 隨時給予精神支持，幫助個案瞭解自己的長處，促進其整體感受，抵消因身體心像改變造成的恐懼。
- (9) 鼓勵個案走出病房，多接觸其它人、事、物，找尋適當方法抒解情緒。
- (10) 介紹相同個案，互相表達感受，彼此交換意見。
- (11) 鼓勵個案習慣別人的眼光，正向的將別人的眼光視為關懷。
- (12) 若發現個案有退縮及拒絕的行為，應瞭解原因並協助解決。

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/13

- (13) 讓個案瞭解疾病過程及疾病對外觀上的改變，如：利用圖片、相片以澄清疑慮。
- (14) 與個案討論並列出失去子宮、輸卵管、卵巢對正常社交生活影響的範圍及因素。
- (15) 個案若有虔誠的宗教信仰，鼓勵可適當的應用，避免負向情緒。
- (16) 協助個案的親人（先生）接受個案失去子宮的事實，常表達關懷，給予安全感。

5. 性生活型態失常／與子宮切除術後有關。

- (1) 主動了解與尊重的態度接受個案對性問題的感受及想法。
- (2) 鼓勵個案與配偶（性伴侶）表達性困擾及性相關的焦慮情緒。
- (3) 完整評估個案性生活形態、性活動頻率、性功能障礙的情況。
- (4) 了解個案對性困擾所產生之性偏見，釐清性問題發生的導因，協助矯正。
- (5) 協助個案與配偶（性伴侶）雙向溝通，建立良好互動，減少性生活恢復過程的壓力。
- (6) 提供書面、衛教單張、錄影帶、幻燈片，待個案與配偶閱閱後，再與個案及配偶（性伴侶）討論，提供正確的性知識，以增強個案與配偶（性伴侶）學習性生活調適之能力。
- (7) 鼓勵個案與配偶（性伴侶）共同參與衛教與性諮商過程。
- (8) 個案呈現情緒障礙或焦慮反應時，應終止會談，並適時提供有力的心理支持，建立性生活的信心，並增強正向的自我概念。
- (9) 衛教個案與配偶（性伴侶）性生活，包括口交、擁抱、親吻、愛撫、自慰、共同沐浴、按摩敏感地帶等，可以透過這些活動一樣可獲得性滿足。
- (10) 當個案出現需要醫療處置之潛在或現存的性問題時，給予適當轉介，如性諮商與行為治療。

（七）衛教指導

1. 飲食方面

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/13

- (1) 一般而言，手術後視醫囑禁食至排氣或數天，或有腸蠕動時，依醫囑可進食。
- (2) 可以開始進食時，應先喝白開水約 30-50c.c.，若無噁心、嘔吐腹脹、腹痛、腸絞痛後，可吃白飯、新鮮自烹白稀飯、麵條等軟質飲食，勿吃太快太多，避免腸絞痛。沒有任何不適時，可以恢復正常飲食，採少量多餐，不要太油膩及太鹹。
- (3) 建議個案 1 週內少攝取刺激性食物如辣椒、咖啡；少進食易產氣食物如牛奶、蛋、豆類製品、地瓜、麵包等，以防腹脹不適；增加水份攝取，以避免便秘；建議 2 週內避免進食含人參、麻油、酒等食物，避免影響傷口癒合。

2. 傷口方面

- (1) 衛教手術後會有 1 個橫式或直式傷口，且必要時醫師有可能會放置傷口引流管，可能會引起身體不適。
- (2) 每班觀察傷口有無紅、腫、熱、痛，或不正常的分泌物及傷口恢復狀況。
- (3) 手術後當天不會換藥，手術後第三天會由醫師換藥，之後每 2 天換藥一次，或視當時傷口情況換藥。
- (4) 換藥步驟及方法：將無菌食鹽水滴至無菌棉棒，以傷口為中心點，由內向外塗擦清潔至傷口周圍外至少 5 公分處，再將無刺激性優點藥水滴至無菌棉棒塗擦消毒，約停留 20-30 秒，最後再使用無菌食鹽水將優點藥水擦去，消毒完畢後再以無菌紗布或無菌敷料覆蓋傷口及黏貼好。
- (5) 教導個案需保持傷口及周圍皮膚清潔與乾燥。
- (6) 教導腹部傷口約 10-14 天癒合，需保持清潔乾燥。
- (7) 出院後建議傷口約 2-3 天換藥，或是不小心弄濕或滲濕時應更換之。

3. 傷口疼痛方面

- (1) 教導在傷口換藥後或下床時使用束腹帶，減少腹部傷口牽扯，減輕傷口疼痛。
- (2) 衛教 4-6 週內避免提重物，若需提 5 公斤以上重物時，建議可使用束腹帶固定傷口，以避免疼痛。

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	10/13

4. 活動方面

- (1) 衛教手術後當天在床上應多翻身或側臥，最好每 2 小時翻身一次，促進血液循環，增加腸蠕動，以預防腸道粘連，並鼓勵個案早期下床活動。
- (2) 手術後第二天盡可能採漸進式下床活動，可以先採半坐臥，若未感不適則可以採坐臥，再坐於床邊，慢慢站起走動，全程需由家屬或朋友陪伴，以防止跌倒之虞。
- (3) 衛教避免長時間坐或站、勿激烈運動，如機車、騎腳踏車、開車長途旅行、爬山、游泳。

5. 衛生方面

- (1) 手術後導尿管一般會留置大約 7-14 天，或是依當時恢復情形而定，導尿管留置期間會給予會陰沖洗及導尿管的護理。依醫囑協助導尿管膀胱訓練，之後再視訓練情形移除導尿管。移除導尿管後，需注意第一次解尿時間（4-6 小時內自解）及記錄排尿量與觀察尿液顏色。若移除導尿管後；無法解尿或是解尿不乾淨會教導自我導尿法，其消毒方式採清潔即可。
- (2) 手術後若陰道有血狀排泄物，應勤換產墊或棉墊，以保持乾淨，避免感染。
- (3) 如廁後衛生紙應由前往後擦拭，勤換棉墊，避免感染。
- (4) 個案身體清潔之照護，手術後先以擦拭方式為主，醫師會視傷口癒合狀況，評估是否可以開始沐浴。若可以沐浴時，建議宜採淋浴方式，勿盆浴及陰道灌洗，以避免傷口感染。

6. 性方面：需在醫師診察傷口癒合後，視情況約 4-6 週可恢復性生活。

7. 其他方面：

- (1) 出院後若有以下情形應立即回診：傷口有紅、腫、熱、痛及滲出液情形；體溫 $>38^{\circ}\text{C}$ 以上；解尿困難、疼痛、頻尿、有灼熱感；陰道出血量多呈鮮紅色、惡臭。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	11/13

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲(2020)·產科護理學(十版)·台北：新文京。
- (二) 王秀紅、柯乃瑩、成令方、林靜儀、陳馥萱、張皓媛、陳淑齡、葉月珍、吳佳儀、方素璿、廖怡惠、楊幸真、蕭秋月、謝秀芬、莊昭華(2021)·當代婦女健康(一版)·台北：華杏。
- (三) 馮容莊、葉月珍、呂美芬、湯玉英、祁安美、林麗珠、李惠玲、潘婉琳、陳淑貞、田聖芳、張芳維、趙興隆、任士熙、張碧芬(2019)·實用婦科護理(六版)·台北：華杏。
- (四) 衛生福利部統計處(2025, 6月16日)·113年死因統計結果·取自 <https://www.mohw.gov.tw/cp-16-82775-1.html>
- (五) Metcalfe, K. A., Price, M. A., Mansfield, C., Hallett, D. C., Lindeman, G. J., Fairchild, A.,...Liede, A. (2020). Predictors of long-term cancer-related distress among female BRCA1 and BRCA2 mutation carriers without a cancer diagnosis: an international analysis. British Journal of Cancer,1-7.doi:10.1038/s41416-020-0861-3

七、附件

(略)

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	12/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	增加及修改定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題及衛教指導之內容	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1.醫護部改護理部 2.修改錯別字	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	1.第三項第(一)、(四)目部份內容刪修 2.更新第六項文獻參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1.第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 2.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.04.11	3.4	第三項第三目之 2、3 部份內容刪修。	107 年 04 月 11 日護理長會議通過
107.09.12	3.5	第三項第三目之說明之 3(4)、(5)及第七目之 1(2)內容修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四目之 3 手術後同 2 剖腹探查術 (Laparotomy；LAPA)。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	卵巢癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	13/13

修正日期	版本	修正說明	備註
		3. 第三項第四目之 5、6 新增根治性全子宮切除、雙側輸卵管卵巢切除及骨盆淋巴結摘除 (RH+BSO+BPLND) 4. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	
109.08.18	3.7	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.09.07	3.8	1. 第三項第一目參考資料更新。 2. 第六項參考資料修訂。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過； 110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	3.9	1. 第三項第四目部分資料數據刪除。 2. 第三項第五、六目之護理問題名稱修訂。 3. 第六項參考資料修訂。 4. 刪除內文參考文獻。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	4.0	修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。